Identifikace pacienta
Jméno pacienta: **Richard**
Příjmení pacienta: **Potužný**
Rodné číslo:
Pojišťovna pacienta:

Zdravotní stav a diagnózy
Anamnéza: **OA: Arteriální hypertenze ICHS - stav po atace nestabilní AP. Koronarograficky nemoc dvou tepen. Dne** 30**.4.2015 provedena PCI na RIA, RCx a RMS s použitím DE stentů. reSKG** 3**/202**3 **Trvající dobrý výsledek předchozích intervencí TTE** 3**/202**3 **Dobrá syst.fce obou srd.komor, Stěny LK bez jednozn.poruch kinetiky,Znákmky por.realxace LK, Malé Mi a Tri insuf. Dyslipidemie na terapii statinem a ezetimib St.p. TURP. Obezita Chronická žilní insuficience otoky DKK po amlodipinu stp. TURP prostaty 5/2026 MNOF - dg. ca hosp. 5/2026, GEO, VTN s dg.: Sepse kombinované etiologie- pneumonie, cholecystitida, uroinfekce v hemokulturách pozitivní Enterococus AKI 3.st.nonoligurické komb. etiol.(dehydratace + sepse) Cholecystitis dle USG Bronchopneumonie NS Hepatopatie, v dif. dg případná monost cirhozy jater, s lab. upravou Makulopapulozní exantém periorálně s exkoriacemi - průkaz HSV-1, přelečen Refluxní esofagitida s vředy Cysty ledvin Nynější epikríza 69-letý pacient přijat akutně pro nález na MR Cp - susp. rozsáhlé zánětlivé změny (spondylodiscitis diff dgmalignί infiltrace? v oblasti C6-Th1. Pacient 4 měsíce po TURP prostaty s následnou sepsí kombinované etiologie. Vstupní laboratoř bez hrubé patologir. Přijat na neurologické standardní oddělení, zalečen dvojkombinaci i.v.ATB. Snimky MR Cp konzultované s neurochirurgií a onkologií FNO a doporučeno doplněni scintigrafie skeletu. V kontrolní laboratoři bez hrubé patologie. Na scintigrafii skeletu popsány osteolytické ložiska C páteře, náznam malého okrsku v kalvě vpravo okcipitálně, malý okrsek také tela Th6 a v kloubním spojení L5-S1, dále taky v.s. cysty ledvin. Dle rekonzultace NCH - nahlásit na NOCO a doplnit CT hrudníku a břicha s kontrastem.**

Zobrazovací vyšetření: **MR Cp** 1**4.9.26 - Výrazná infiltrace obr. těl C6/C7/Th1 vč. pediklů a neuroforamin vpravo, postkontrastně se sytící, parc. až kompletní zánik meziobr. prostor C6-Th1. Komprese těla C6. Zesílení podélných vazů a dury se stenotizací pát. kanálu C6-Th1 (t.č. bez komprese míchy či myelopathie). Edém měkkých tkání retrofaryng. prostoru. Dif.dg.: susp. rozsáhlé zánětlivé změny (spondylodiscitis?) / maligní infiltrace? (CAVE pac. s CA prostaty v anamnéze). NUTNÉ DOŠETŘIT, KONZULTACE S NEUROCHIR., ONKOL. ... Labor. výsledky (PSA? atd.). - Neuroforaminostenóza bilat. C4/5 osteogenně. - Postkontrastně mozk. parenchym bez sytících se ložisek. snímky zaslány ePACs scintigrafie skeletu**